

Observation médicale :

Identité :

Il s'agit de Mr/Mme, âgé(e) de Ans,
originaire de, marié(e) / célibataire / divorcé(e),
consanguinitéprofession :,
Couverture sociale (AMO Tadamon - CNSS - autre) :

Motif de consultation : (les signes majeurs qui ont poussé le patient a consulté)

Antécédents :

Personnels :

➤ Médicaux :

- HTA
- Diabète
- cardiopathie ou de néphropathie ou d'hépatopathie connue
- Tuberculose ou de contage tuberculeux connu.
- Néoplasie connue.
- Maladie de système ou d'endocrinopathie connue
- Hospitalisation précédentes :
 - Lieu :
 - Motif :
 - Date :

➤ Chirurgicaux :

- Césariennes : nombre, motif, conditions obstétricales etc
- Autres interventions plus particulièrement les antécédents de chirurgie gynécologique et digestive (coélioscopie, cure de synéchies, myomectomie...) :
- Patient opéré pour :
 - Motif :

- Date :
- Lieu :

⇒ **Toxico-allergique :**

- Allergie connue
- Patient connu tabagique chronique à raison de paquet /année.
- Notion d'éthylisme.

⇒ **Médicamenteux :**

- Prise médicamenteuse au long court.

⇒ **Gynéco-obstétrique :**

• **Gynécologiques :**

- Âge des premières ménarches :
- Cycle menstruel :
 - Régularité :
 - Abondance des règles (nombre de serviettes hygiéniques) :
 - Date des dernières règles :
 - Syndrome prémenstruel :
- Contraception (type, durée et observance, complications) :
- Pré-ménopause ou ménopause (âge de survenu, traitements, troubles):
- L'existence de malformations utérines, d'infections génitales évolutives ou récentes, isolées ou répétées
- Traitements au laser, traitements par inducteurs de l'ovulation
- Mastopathie bénigne (maladie fibro-kystique)

• **Obstétricaux :**

- Nombre de Grossesse et de parité GxPx
- Dates, déroulement des grossesses :
- Voies et modalités d'accouchement :
- Sexe et poids à la naissance :
- Développement psychomoteur :
- Fausse couches :

-Pathologie des grossesses, des accouchements et des suites de couche (môle hydatiforme, antécédent d'ictère cholestatique, de pré-éclampsie, d'hémorragie, de déchirures compliquées, complications infectieuses ou thromboemboliques) :

Familiaux :

-Maladies générales : diabète, HTA, hypercholestérolémie familiale, pathologie thromboembolique ou cardio-vasculaire,

-Pathologie tumorale : cancer du sein et cancer pelvien (cas similaire dans la famille sœur, mère et tante) :

-Maladies familiales génétiques :

- Cas similaire de maladie :

- Autres :

Conjoint :

-Changement de conjoint :

-Pathologie du ou des conjoints :

-Partenaires multiples :

Histoire de maladie :

L'histoire de maladie remonte à, le patient s'est présenté avec (signes fonctionnelles positives)

.....

.....

..... Sans (signes fonctionnelles négatives)

.....

.....

Évolution:.....quand?.....

Retentissement sur l'état général (AEG) :

Dans un contexte (anémique - hémorragique - tumorale - infectieux):

.....

Ce qui a poussé ce(cette) patient(e) a consulté chez

.....

Traitements / transfusions reçu :

.....

Bilans demandés :

.....

Examen général :

-État de conscience (GCS) :

- FR :/min FC:/min T°: PA: SaO2:

-Poids : Taille : IMC :(<19: dénutrition et > 30: obésité)

- Etat des Conjonctives :

Examen gynécologique : asepsie rigoureuse ++++

➤ Au speculum :

-Position du col : postérieur, latéralisé ...

-Aspect du col :

- Couleur : rose, rouge, violacé (grossesse, molle etc)
- Aspect bourgeonnant, saignant au contact (suspect)
- Leucorrhée, métrorragie etc

➤Au Toucher vaginal (contre indiqué si placenta praevia et si jeune fille vierge faire : toucher rectal)

-Taille :

-Consistance : molle, dure

-Sensibilité :

-Cri de douglas :

-Présence ou pas de masse ou de douleur latéro-utérine

-Poche des eaux intactes ou pas en cas de grossesse

Conclusion :

Il s'agit de Mme/Mr, âgé(e) de ans,
(ATCD).....

.....,

Qui a présenté depuis, (signes fonctionnelles positives)
.....,

Chez qui l'examen clinique a trouvé (regroupement syndromique)
.....

Diagnostics à évoquer

- Causes gynécologiques :
- Causes extra gynécologiques :